Morpheo v2.0

Informe de viñetas para revisión clínica

Embudo v0.2 · contenido 2.0-draft · 19 de octubre de 2026 · para revisión clínica

Qué es

Doce casos simulados recorren la entrevista de v0.2 tal como la haría la aplicación. Ocho son las pruebas funcionales de la p. 14 de v0.2; cuatro son casos límite: insomnio con ideación suicida, conductor profesional con somnolencia, duración desconocida, e insomnio con posible apnea. Todos son casos de prueba que puedes corregir o sustituir por los tuyos. v2.0 sigue desactivada: nadie la ve todavía.

Cómo leer cada página

- Caso: lo que cuenta la persona al empezar.
- Resultado: ramas abiertas, reglas aplicadas, acción principal y datos que faltan.
- Texto final: exactamente lo que vería la persona al terminar.
- Preguntas y respuestas: todas, en el orden en que se hacen. Las respuestas marcadas «(supuesta)», en naranja y con fondo amarillo, no las define el caso: son respuestas realistas para esa persona, añadidas para poder llegar al final.
- Los huecos [..] de las plantillas se rellenan con frases de un catálogo cerrado (página final). Nunca se copian las palabras de la persona.

Resumen: 12 de 12 casos dan el resultado esperado

Caso	Qué prueba	Preguntas	Acción principal	Textos
FT-1	Insomnio persistente sin otras señales	29	Terapia (TCC-I)	Insomnio
FT-2	Mismo caso + pausas observadas	35	Consulta / estudio	Insomnio y respiración
FT-3	Solo 5 horas disponibles por trabajo	32	Hábitos	Hábitos
FT-4	Vive solo, desconoce el ronquido y se duerme al volante	38	Evaluación prioritaria	Aviso de conducción, Somnolencia, Respiración
FT-5	Estudio domiciliario negativo y sospecha vigente	34	Consulta / estudio	Polisomnografía
FT-6	Bipolaridad e insomnio	29	Terapia (TCC-I)	Insomnio
FT-7	Duración desconocida	31	Información insuficiente	Información incompleta
FT-8	Piernas con patrón completo	30	Consulta / estudio	Piernas
V-09	Insomnio con ideación suicida	5	Emergencia	Seguridad
V-10	Conductor profesional con somnolencia	43	Evaluación prioritaria	Aviso de conducción, Somnolencia, Respiración, Horario
V-11	Duración desconocida, frecuencia no respondida y mucho impacto	31	Información insuficiente	Información incompleta
V-12	Insomnio y posible apnea, con complejidad	35	Consulta / estudio	Insomnio y respiración, Polisomnografía

Para decidir: las entrevistas completas tienen entre 29 y 43 preguntas (V-09 se detiene en la pregunta 5). ¿Es una longitud aceptable para una primera consulta, o conviene acortarla?

FT-1 · Insomnio persistente sin otras señales

V0.2 p. 14, prueba 1

Caso

«Desde hace unos seis meses me despierto casi todas las noches y me cuesta volver a dormirme.»

Preguntas y respuestas, en orden (29 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	52 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Volver a dormir del tirón y no desvelarme a las tres de la mañana» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	6 meses
7	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	Sí «Empecé en un puesto nuevo con más responsabilidad» **(supuesta)**
8	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	4 noches por semana
9	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Me duermo bien, pero hacia las tres me despierto y tardo más de una hora en volver a dormirme» **(supuesta)**
10	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 23:15 · intenta dormir: 23:30 · se despierta: 06:45 · se levanta: 07:00 **(supuesta)**
11	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	despertares
12	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	5 horas **(supuesta)**
13	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«Voy cansado al trabajo y por la tarde me cuesta concentrarme» **(supuesta)**
14	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio
15	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	No **(supuesta)**
16	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí
17	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Nada en especial; no tomo medicación» **(supuesta)**
18	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ninguna de estas
19	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No
20	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No
21	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No
22	**I1** · ¿Le cuesta dormir incluso cuando tiene tiempo y un lugar adecuados?	Sí
23	**I2** · ¿Esto afecta a su día a día o le produce un malestar importante?	Sí
24	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
25	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
26	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
27	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
28	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
29	**Z1** · Esto es lo que he entendido: se despierta varias veces por la noche; le ocurre 4 noches por semana; desde hace 6 meses; durante el día nota cansancio. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
30	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Unas pautas que pueda seguir entre semana» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	I · Dificultad para dormir: ¿terapia o apoyo?
Reglas aplicadas	R04 · Insomnio persistente → Terapia (TCC-I) (Insomnio)
Acción principal	Terapia (TCC-I)
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Ninguno

Texto final, tal como lo vería la persona

Nos ha contado que se despierta varias veces por la noche, 4 noches por semana y desde hace 6 meses, incluso cuando puede dormir. Además, esto afecta a su día a día y nota cansancio. Esto encaja con un posible insomnio persistente. Le proponemos una terapia específica para el insomnio, llamada TCC-I. Ayuda a cambiar hábitos y preocupaciones que mantienen el problema. Un profesional puede confirmar que es adecuada para usted y decidir si necesita algún ajuste. Por ahora, lo que cuenta no indica que necesite un estudio del sueño de forma rutinaria.

De dónde sale cada párrafo: 1) Insomnio: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: DIF-02, FRE-02, Z1-01, Z1-02, Z1-03, Z1-04, DUR-01, IMP-03.

FT-2 · Mismo caso + pausas observadas

V0.2 p. 14, prueba 2

Caso

«Desde hace seis meses me despierto muchas noches y mi mujer dice que a veces dejo de respirar.»

Preguntas y respuestas, en orden (35 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	58 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Dormir de un tirón y que mi mujer deje de preocuparse» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	6 meses
7	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	No **(supuesta)**
8	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	4 noches por semana
9	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Me despierto dos o tres veces cada noche y a veces con la boca muy seca» **(supuesta)**
10	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 23:00 · intenta dormir: 23:15 · se despierta: 06:30 · se levanta: 06:45 **(supuesta)**
11	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	despertares
12	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	5 horas **(supuesta)**
13	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«Por la tarde me cuesta mantener la atención en las reuniones» **(supuesta)**
14	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio
15	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	No **(supuesta)**
16	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí **(supuesta)**
17	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Nada en especial» **(supuesta)**
18	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	le han visto dejar de respirar
19	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
20	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
21	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No **(supuesta)**
22	**I1** · ¿Le cuesta dormir incluso cuando tiene tiempo y un lugar adecuados?	Sí
23	**I2** · ¿Esto afecta a su día a día o le produce un malestar importante?	Sí
24	**R2a** · ¿Ronca a menudo?	Sí **(supuesta)**
25	**R2b** · ¿Se duerme sin querer?	No **(supuesta)**
26	**R2c** · ¿Tiene la tensión alta?	No **(supuesta)**
27	**R3** · ¿Duerme solo o no sabe si ronca?	No **(supuesta)**
28	**R4** · Si hay sospecha: ¿hay enfermedad cardiopulmonar relevante, ictus, opioides, debilidad respiratoria o insomnio grave?	Ninguna de estas **(supuesta)**
29	**R6** · ¿Ya hubo un estudio respiratorio domiciliario negativo, dudoso o no válido?	No **(supuesta)**
30	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
31	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
32	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
33	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
34	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
35	**Z1** · Esto es lo que he entendido: se despierta varias veces por la noche; le ocurre 4 noches por semana; desde hace 6 meses; durante el día nota cansancio; ha descrito ronquido frecuente y pausas al respirar que otras personas han observado. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
36	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Saber qué prueba me tocaría y cuándo» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	I · Dificultad para dormir: ¿terapia o apoyo?; R · Respiración: elegir la evaluación adecuada
Reglas aplicadas	R05 · Sospecha respiratoria; R08 · Prioridad y combinaciones → Consulta / estudio (Insomnio y respiración)
Acción principal	Consulta / estudio
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Ninguno

Texto final, tal como lo vería la persona

Ha contado dificultades persistentes para dormir y también señales respiratorias como ronquido frecuente y pausas al respirar que otras personas han observado. Pueden coexistir dos problemas. Conviene estudiar su respiración y valorar al mismo tiempo una terapia para el insomnio. El profesional organizará ambos pasos y adaptará el tratamiento si tiene mucho sueño durante el día.

De dónde sale cada párrafo: 1) Insomnio y respiración: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: DIF-02, FRE-02, RES-02, RES-03, Z1-01, Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-07.

FT-3 · Solo 5 horas disponibles por trabajo

V0.2 p. 14, prueba 3

Caso

«Trabajo muchas horas y solo puedo dormir unas cinco. Cuando duermo, duermo bien.»

Preguntas y respuestas, en orden (32 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	34 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Rendir mejor y no depender tanto del café» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	1 año
7	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	Sí «Me ascendieron y desde entonces salgo muy tarde» **(supuesta)**
8	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	5 noches por semana
9	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Me acuesto a la una, me duermo enseguida y a las seis suena el despertador» **(supuesta)**
10	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 01:00 · intenta dormir: 01:00 · se despierta: 06:00 · se levanta: 06:00 **(supuesta)**
11	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	Ninguna de estas
12	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	5 horas
13	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«A media tarde me noto lento y con la cabeza pesada» **(supuesta)**
14	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio **(supuesta)**
15	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	Sí **(supuesta)**
16	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	No
17	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Nada en especial» **(supuesta)**
18	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ninguna de estas **(supuesta)**
19	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
20	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
21	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	Sí
22	**H2** · ¿A qué hora le entra sueño y a qué hora se despierta sin despertador?	A qué hora le entra sueño: 23:00 · a qué hora se despierta sin despertador: 08:30 **(supuesta)**
23	**H3a** · ¿Su horario de trabajo o de cuidados le obliga a dormir a otra hora?	No **(supuesta)**
24	**H3b** · ¿Hace turnos?	No **(supuesta)**
25	**H4** · ¿Duerme poco porque no puede reservar más tiempo, aunque dormiría más?	Sí
26	**H5** · ¿Este patrón se mantiene, le afecta mucho o persiste pese a poder descansar?	No **(supuesta)**
27	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
28	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
29	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
30	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
31	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
32	**Z1** · Esto es lo que he entendido: le ocurre 5 noches por semana; desde hace 1 año; durante el día nota cansancio; no siempre tiene tiempo o un lugar adecuados para dormir; duerme mejor cuando puede elegir su horario. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
33	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Poder organizar mejor las horas de trabajo» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	H · Horario desajustado o sueño insuficiente
Reglas aplicadas	R06 · Hábitos o cuadro reciente → Hábitos (Hábitos)
Acción principal	Hábitos
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Ninguno

Texto final, tal como lo vería la persona

Por lo que cuenta, sus horarios o el poco tiempo que tiene para descansar pueden estar influyendo en cómo duerme. Podemos empezar por proteger un tiempo fijo para descansar y anotar cómo le va durante una o dos semanas. Revisaremos si nota mejoría. Si empeora o le afecta mucho durante el día, pida una valoración antes.

De dónde sale cada párrafo: 1) Hábitos: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: FRE-02, Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-10, Z1-11, HAB-01.

FT-4 · Vive solo, desconoce el ronquido y se duerme al volante

V0.2 p. 14, prueba 4

Caso

«Vivo solo y me noto con mucho sueño durante el día.»

Preguntas y respuestas, en orden (38 preguntas y 2 textos para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	61 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Estar despierto durante el día y quedarme tranquilo» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	3 meses **(supuesta)**
7	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	No **(supuesta)**
8	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	2 noches por semana **(supuesta)**
9	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Duermo de un tirón, pero me levanto cansado» **(supuesta)**
10	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 23:00 · intenta dormir: 23:15 · se despierta: 07:00 · se levanta: 07:30 **(supuesta)**
11	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	Ninguna de estas **(supuesta)**
12	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	7 horas **(supuesta)**
13	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«Me entra mucho sueño después de comer y a media tarde» **(supuesta)**
14	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	quedarse dormido sin querer
15	**S2 (en ese momento)** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño? *Se pregunta en ese momento porque en Q11 dijo que llega a quedarse dormido sin querer (D-37).*	Sí
16	**Aviso (S2)** · Si conduce o maneja maquinaria, sobre todo por trabajo, lo más seguro es que no lo haga mientras tenga este sueño y hasta que un profesional lo valore. Si el sueño le sorprende al volante, pare en cuanto pueda en un lugar seguro y descanse. La somnolencia suele tener solución, y por eso merece la pena pedir esa valoración pronto. Si conduce por trabajo, el servicio de salud laboral de su empresa también puede ayudarle. *Texto nuevo (AVISO-S2): se muestra en cuanto responde «Sí» a S2, antes de seguir (v0.2 p. 10: «primero advertencia»).*	Leído
17	**Lugar seguro (S2)** · Antes de seguir: ¿está ahora en un lugar seguro, sin conducir ni manejar maquinaria? *Pregunta nueva (SEGURO-S2): la entrevista solo sigue si responde «Sí»; si no, se pausa (v0.2 p. 10).*	Sí
18	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	Sí **(supuesta)**
19	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí **(supuesta)**
20	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Nada en especial» **(supuesta)**
21	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	No lo sé
22	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
23	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
24	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No **(supuesta)**
25	**R1** · ¿Hay pausas observadas o despertares repetidos con sensación de ahogo?	No lo sé
26	**R2a** · ¿Ronca a menudo?	No lo sé
27	**R2b** · ¿Se duerme sin querer?	Sí
28	**R2c** · ¿Tiene la tensión alta?	No **(supuesta)**
29	**R3** · ¿Duerme solo o no sabe si ronca?	Sí
30	**R4** · Si hay sospecha: ¿hay enfermedad cardiopulmonar relevante, ictus, opioides, debilidad respiratoria o insomnio grave?	Ninguna de estas **(supuesta)**
31	**R6** · ¿Ya hubo un estudio respiratorio domiciliario negativo, dudoso o no válido?	No **(supuesta)**
32	**D2a** · ¿Continúa pese a dormir suficiente?	No **(supuesta)**
33	**D2b** · ¿Pierde fuerza al reírse, sin perder el conocimiento?	No **(supuesta)**
34	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
35	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
36	**S2 (confirmación)** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
37	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
38	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
39	**Z1** · Esto es lo que he entendido: le ocurre 2 noches por semana; desde hace 3 meses; durante el día a veces le vence el sueño sin querer; ha descrito tendencia a dormirse sin querer durante el día y dudas sobre si ronca o hace pausas al dormir. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
40	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Saber si necesito alguna prueba» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	R · Respiración: elegir la evaluación adecuada; D · Somnolencia
Reglas aplicadas	R01 · Alertas → Evaluación prioritaria (Somnolencia); R05 · Sospecha respiratoria → Consulta / estudio (Respiración)
Acción principal	Evaluación prioritaria
Otras acciones	Consulta / estudio
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Ninguno

Texto final, tal como lo vería la persona

Si conduce o maneja maquinaria, sobre todo por trabajo, lo más seguro es que no lo haga mientras tenga este sueño y hasta que un profesional lo valore. Si el sueño le sorprende al volante, pare en cuanto pueda en un lugar seguro y descanse. La somnolencia suele tener solución, y por eso merece la pena pedir esa valoración pronto. Si conduce por trabajo, el servicio de salud laboral de su empresa también puede ayudarle.

Quedarse dormido sin querer merece una valoración, especialmente si ocurre aunque pueda descansar. Si le pasa conduciendo, no conduzca y busque ayuda médica con prioridad.

Algunas señales que ha contado, como tendencia a dormirse sin querer durante el día y dudas sobre si ronca o hace pausas al dormir, hacen pensar que su respiración podría interrumpirse mientras duerme. La conversación no permite saberlo con seguridad. Le recomendamos una valoración para decidir qué estudio del sueño necesita. En algunas personas puede hacerse en casa; en otras conviene un estudio más completo.

De dónde sale cada párrafo: 1) Aviso de conducción: texto nuevo, pendiente de aprobación · 2) Somnolencia: plantilla de v0.2 · 3) Respiración: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: AVISO-S2, SEGURO-S2, FRE-02, RES-06, RES-08, Z1-02, Z1-03, Z1-05, Z1-07.

FT-5 · Estudio domiciliario negativo y sospecha vigente

V0.2 p. 14, prueba 5

Caso

«Ronco muy fuerte y tengo la tensión alta. Ya me hicieron un estudio en casa y salió bien.»

Preguntas y respuestas, en orden (34 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	47 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Despertarme descansado» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	2 años **(supuesta)**
7	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	No **(supuesta)**
8	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	6 noches por semana **(supuesta)**
9	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Me duermo enseguida, ronco mucho y me levanto como si no hubiera dormido» **(supuesta)**
10	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 23:30 · intenta dormir: 23:30 · se despierta: 07:00 · se levanta: 07:15 **(supuesta)**
11	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	Ninguna de estas
12	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	7 horas **(supuesta)**
13	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«Me cuesta arrancar por la mañana» **(supuesta)**
14	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio **(supuesta)**
15	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	No **(supuesta)**
16	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí **(supuesta)**
17	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Tomo un medicamento para la tensión» **(supuesta)**
18	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ronca fuerte
19	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
20	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
21	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No **(supuesta)**
22	**R1** · ¿Hay pausas observadas o despertares repetidos con sensación de ahogo?	No **(supuesta)**
23	**R2a** · ¿Ronca a menudo?	Sí
24	**R2b** · ¿Se duerme sin querer?	No **(supuesta)**
25	**R2c** · ¿Tiene la tensión alta?	Sí
26	**R3** · ¿Duerme solo o no sabe si ronca?	No **(supuesta)**
27	**R4** · Si hay sospecha: ¿hay enfermedad cardiopulmonar relevante, ictus, opioides, debilidad respiratoria o insomnio grave?	Ninguna de estas **(supuesta)**
28	**R6** · ¿Ya hubo un estudio respiratorio domiciliario negativo, dudoso o no válido?	Sí
29	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
30	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
31	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
32	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
33	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
34	**Z1** · Esto es lo que he entendido: le ocurre 6 noches por semana; desde hace 2 años; durante el día nota cansancio; ha descrito ronquido fuerte y tensión arterial alta. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
35	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Que me digan si hace falta repetir la prueba» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	R · Respiración: elegir la evaluación adecuada
Reglas aplicadas	R05 · Sospecha respiratoria → Consulta / estudio (Polisomnografía)
Acción principal	Consulta / estudio
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Polisomnografía
Datos que faltan	Ninguno

Texto final, tal como lo vería la persona

Por un estudio del sueño en casa que no permitió aclarar el problema, conviene que le valore un especialista del sueño. Es recomendable que valore una polisomnografía: una prueba que registra cómo duerme, cómo respira y sus movimientos. El profesional confirmará qué prueba aporta más información en su caso.

De dónde sale cada párrafo: 1) Polisomnografía: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: FRE-02, RES-01, RES-07, Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-07, PSG-07.

FT-6 · Bipolaridad e insomnio

V0.2 p. 14, prueba 6

Caso

«Me despierto casi todas las noches desde hace meses.»

Preguntas y respuestas, en orden (29 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	39 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Dormir más horas seguidas sin desvelarme» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	6 meses
7	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	No **(supuesta)**
8	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	4 noches por semana
9	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Me duermo a la primera, pero me despierto varias veces y me cuesta volver a dormir» **(supuesta)**
10	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 00:00 · intenta dormir: 00:15 · se despierta: 07:00 · se levanta: 07:30 **(supuesta)**
11	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	despertares
12	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	5 horas **(supuesta)**
13	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«Estoy más irritable y me cuesta concentrarme» **(supuesta)**
14	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio **(supuesta)**
15	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	No **(supuesta)**
16	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí **(supuesta)**
17	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Tengo trastorno bipolar y tomo litio»
18	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ninguna de estas **(supuesta)**
19	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
20	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
21	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No **(supuesta)**
22	**I1** · ¿Le cuesta dormir incluso cuando tiene tiempo y un lugar adecuados?	Sí
23	**I2** · ¿Esto afecta a su día a día o le produce un malestar importante?	Sí
24	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
25	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
26	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
27	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
28	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
29	**Z1** · Esto es lo que he entendido: se despierta varias veces por la noche; le ocurre 4 noches por semana; desde hace 6 meses; durante el día nota cansancio; tiene un trastorno bipolar. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
30	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Que tengan en cuenta mi tratamiento» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	I · Dificultad para dormir: ¿terapia o apoyo?
Reglas aplicadas	R04 · Insomnio persistente → Terapia (TCC-I) (Insomnio)
Acción principal	Terapia (TCC-I)
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Ninguno
Indicadores	Adaptar la terapia antes de empezar (R07)

Texto final, tal como lo vería la persona

Nos ha contado que se despierta varias veces por la noche, 4 noches por semana y desde hace 6 meses, incluso cuando puede dormir. Además, esto afecta a su día a día y nota cansancio. Esto encaja con un posible insomnio persistente. Le proponemos una terapia específica para el insomnio, llamada TCC-I. Ayuda a cambiar hábitos y preocupaciones que mantienen el problema. Un profesional puede confirmar que es adecuada para usted y decidir si necesita algún ajuste. Por ahora, lo que cuenta no indica que necesite un estudio del sueño de forma rutinaria.

De dónde sale cada párrafo: 1) Insomnio: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: DIF-02, FRE-02, Z1-01, Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-12, DUR-01, IMP-03.

FT-7 · Duración desconocida

V0.2 p. 14, prueba 7

Caso

«Me cuesta mucho dormirme, no sabría decir desde cuándo.»

Preguntas y respuestas, en orden (31 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	44 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Dormirme antes y no dar tantas vueltas en la cama» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	No lo sé
7	**Q03 (aclaración)** · ¿Desde cuándo le ocurre? *Respondió «No lo sé»: se pregunta una vez más, y solo una (D-08).*	No lo sé
8	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	No **(supuesta)**
9	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	4 noches por semana
10	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Me acuesto y tardo más de una hora en dormirme; luego ya duermo seguido» **(supuesta)**
11	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 23:00 · intenta dormir: 23:00 · se despierta: 07:00 · se levanta: 07:10 **(supuesta)**
12	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	dormirse
13	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	6 horas **(supuesta)**
14	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«Me noto cansado y de peor humor» **(supuesta)**
15	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio **(supuesta)**
16	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	No **(supuesta)**
17	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí **(supuesta)**
18	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Nada en especial» **(supuesta)**
19	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ninguna de estas **(supuesta)**
20	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
21	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
22	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No **(supuesta)**
23	**I1** · ¿Le cuesta dormir incluso cuando tiene tiempo y un lugar adecuados?	Sí
24	**I2** · ¿Esto afecta a su día a día o le produce un malestar importante?	Sí
25	**I3** · ¿Ocurre al menos 3 noches por semana y desde hace 3 meses o más?	No lo sé
26	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
27	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
28	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
29	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
30	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
31	**Z1** · Esto es lo que he entendido: le cuesta dormirse; le ocurre 4 noches por semana; durante el día nota cansancio. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
32	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Que me ayuden a relajarme antes de dormir» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	I · Dificultad para dormir: ¿terapia o apoyo?
Reglas aplicadas	R02 · Edad y datos que faltan → Información insuficiente (Información incompleta)
Acción principal	Información insuficiente
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Q03 (desde cuándo)

Texto final, tal como lo vería la persona

Todavía me falta saber desde cuándo le ocurre para orientarle mejor. Puede responder de forma aproximada o decir que no lo sabe. Si prefiere no seguir y el problema persiste o le afecta mucho, puede consultar con un profesional.

De dónde sale cada párrafo: 1) Información incompleta: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: DIF-01, FRE-02, Z1-01, Z1-02, Z1-04, DAT-06.

FT-8 · Piernas con patrón completo

V0.2 p. 14, prueba 8

Caso

«Por la noche noto una molestia en las piernas que me obliga a moverlas y no me deja dormir.»

Preguntas y respuestas, en orden (30 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	66 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Poder estar tranquila en la cama y dormirme» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	8 meses **(supuesta)**
7	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	No **(supuesta)**
8	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	5 noches por semana **(supuesta)**
9	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Al acostarme noto las piernas inquietas y tengo que levantarme a caminar» **(supuesta)**
10	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 22:30 · intenta dormir: 23:00 · se despierta: 07:30 · se levanta: 08:00 **(supuesta)**
11	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	dormirse
12	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	6 horas **(supuesta)**
13	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«Por la mañana me noto cansada» **(supuesta)**
14	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio **(supuesta)**
15	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	Sí **(supuesta)**
16	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí **(supuesta)**
17	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Nada en especial» **(supuesta)**
18	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ninguna de estas **(supuesta)**
19	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	Sí
20	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
21	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No **(supuesta)**
22	**I1** · ¿Le cuesta dormir incluso cuando tiene tiempo y un lugar adecuados?	Sí
23	**I2** · ¿Esto afecta a su día a día o le produce un malestar importante?	No
24	**P2** · ¿Ocurre en reposo, mejora con movimiento y es peor por la tarde o noche?	Sí
25	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
26	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
27	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
28	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
29	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
30	**Z1** · Esto es lo que he entendido: le cuesta dormirse; le ocurre 5 noches por semana; desde hace 8 meses; durante el día nota cansancio; nota una molestia en las piernas que le obliga a moverlas al descansar. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
31	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Saber qué me pasa en las piernas» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	I · Dificultad para dormir: ¿terapia o apoyo?; P · Piernas
Reglas aplicadas	R08 · Prioridad y combinaciones → Consulta / estudio (Piernas)
Acción principal	Consulta / estudio
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Ninguno

Texto final, tal como lo vería la persona

Lo que cuenta podría encajar con piernas inquietas. Conviene una consulta para revisar otras causas y decidir si hace falta una analítica. No suele necesitar un estudio del sueño de entrada.

De dónde sale cada párrafo: 1) Piernas: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: DIF-01, FRE-02, Z1-01, Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-08.

V-09 · Insomnio con ideación suicida

Caso límite

Caso

«Llevo meses sin dormir bien y estoy muy cansada. A veces pienso que lo mejor sería quitarme la vida.»

S4 se contesta «No» al principio; el relato la hace preguntar otra vez en ese momento (D-01).

Preguntas y respuestas, en orden (5 preguntas)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	29 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**S4 (en ese momento)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Se pregunta en ese momento porque el relato dice «quitarme la vida».*	Sí

Resultado

Ramas abiertas	Ninguna
Reglas aplicadas	R01 · Alertas → Emergencia (Seguridad)
Acción principal	Emergencia
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Ninguno
Detención	La entrevista se detiene: S4 = Sí

Texto final, tal como lo vería la persona

Lo que describe necesita atención antes de seguir hablando de hábitos de sueño. No tiene que pasar por esto a solas. Puede llamar ahora al 024 (línea de atención a la conducta suicida): es gratuita, confidencial y atiende las 24 horas del día. Si siente que el peligro es inmediato, llame al 112. Podemos retomar esta conversación después.

De dónde sale cada párrafo: 1) Seguridad: plantilla de v0.2 con la acción nueva, pendiente de aprobación. Frases y textos a aprobar que usa este caso: SEG-S4.

V-10 · Conductor profesional con somnolencia

Caso límite

Caso

«Soy camionero y hago rutas largas de noche. Últimamente me cuesta mantenerme despierto.»

S2 se pregunta en cuanto el relato dice «camionero»: primero el aviso y la pregunta de lugar seguro; después no se repite tras Q11 ni al final (se confirma). Duerme de día: su horario es de trabajo nocturno.

Preguntas y respuestas, en orden (43 preguntas y 2 textos para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	50 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**S2 (en ese momento)** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño? *Se pregunta en ese momento porque el relato dice «camión, camionero».*	Sí
6	**Aviso (S2)** · Si conduce o maneja maquinaria, sobre todo por trabajo, lo más seguro es que no lo haga mientras tenga este sueño y hasta que un profesional lo valore. Si el sueño le sorprende al volante, pare en cuanto pueda en un lugar seguro y descanse. La somnolencia suele tener solución, y por eso merece la pena pedir esa valoración pronto. Si conduce por trabajo, el servicio de salud laboral de su empresa también puede ayudarle. *Texto nuevo (AVISO-S2): se muestra en cuanto responde «Sí» a S2, antes de seguir (v0.2 p. 10: «primero advertencia»).*	Leído
7	**Lugar seguro (S2)** · Antes de seguir: ¿está ahora en un lugar seguro, sin conducir ni manejar maquinaria? *Pregunta nueva (SEGURO-S2): la entrevista solo sigue si responde «Sí»; si no, se pausa (v0.2 p. 10).*	Sí
8	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Llegar despejado al final de la ruta» **(supuesta)**
9	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	4 meses **(supuesta)**
10	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	Sí «Desde que hago solo rutas de noche» **(supuesta)**
11	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	3 noches por semana **(supuesta)**
12	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Llego a casa sobre las ocho, me acuesto y de día duermo a ratos por el ruido de la calle» **(supuesta)**
13	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 08:30 · intenta dormir: 09:00 · se despierta: 14:30 · se levanta: 15:00
14	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	Ninguna de estas **(supuesta)**
15	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	5 horas **(supuesta)**
16	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«En la segunda mitad de la ruta me cuesta mucho mantenerme despierto» **(supuesta)**
17	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	quedarse dormido sin querer
18	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	Sí **(supuesta)**
19	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	No **(supuesta)**
20	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Tomo pastillas para la tensión» **(supuesta)**
21	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ronca fuerte
22	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
23	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
24	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	Sí **(supuesta)**
25	**R1** · ¿Hay pausas observadas o despertares repetidos con sensación de ahogo?	No **(supuesta)**
26	**R2a** · ¿Ronca a menudo?	Sí
27	**R2b** · ¿Se duerme sin querer?	Sí
28	**R2c** · ¿Tiene la tensión alta?	Sí
29	**R3** · ¿Duerme solo o no sabe si ronca?	No **(supuesta)**
30	**R4** · Si hay sospecha: ¿hay enfermedad cardiopulmonar relevante, ictus, opioides, debilidad respiratoria o insomnio grave?	Ninguna de estas **(supuesta)**
31	**R6** · ¿Ya hubo un estudio respiratorio domiciliario negativo, dudoso o no válido?	No **(supuesta)**
32	**H2** · ¿A qué hora le entra sueño y a qué hora se despierta sin despertador?	A qué hora le entra sueño: 23:00 · a qué hora se despierta sin despertador: 07:00 **(supuesta)**
33	**H3a** · ¿Su horario de trabajo o de cuidados le obliga a dormir a otra hora?	Sí **(supuesta)**
34	**H3b** · ¿Hace turnos?	No **(supuesta)**
35	**H4** · ¿Duerme poco porque no puede reservar más tiempo, aunque dormiría más?	No **(supuesta)**
36	**H5** · ¿Este patrón se mantiene, le afecta mucho o persiste pese a poder descansar?	No **(supuesta)**
37	**D2a** · ¿Continúa pese a dormir suficiente?	No **(supuesta)**
38	**D2b** · ¿Pierde fuerza al reírse, sin perder el conocimiento?	No **(supuesta)**
39	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
40	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
41	**S2 (confirmación)** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
42	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
43	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
44	**Z1** · Esto es lo que he entendido: le ocurre 3 noches por semana; desde hace 4 meses; durante el día a veces le vence el sueño sin querer; ha descrito ronquido fuerte, tendencia a dormirse sin querer durante el día y tensión arterial alta; no siempre tiene tiempo o un lugar adecuados para dormir; duerme mejor cuando puede elegir su horario. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
45	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Poder hacer la consulta sin perder días de trabajo» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	R · Respiración: elegir la evaluación adecuada; H · Horario desajustado o sueño insuficiente; D · Somnolencia
Reglas aplicadas	R01 · Alertas → Evaluación prioritaria (Somnolencia); R05 · Sospecha respiratoria → Consulta / estudio (Respiración); R08 · Prioridad y combinaciones → Hábitos (Horario)
Acción principal	Evaluación prioritaria
Otras acciones	Consulta / estudio, Hábitos
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	Ninguno

Texto final, tal como lo vería la persona

Si conduce o maneja maquinaria, sobre todo por trabajo, lo más seguro es que no lo haga mientras tenga este sueño y hasta que un profesional lo valore. Si el sueño le sorprende al volante, pare en cuanto pueda en un lugar seguro y descanse. La somnolencia suele tener solución, y por eso merece la pena pedir esa valoración pronto. Si conduce por trabajo, el servicio de salud laboral de su empresa también puede ayudarle.

Quedarse dormido sin querer merece una valoración, especialmente si ocurre aunque pueda descansar. Si le pasa conduciendo, no conduzca y busque ayuda médica con prioridad.

Algunas señales que ha contado, como ronquido fuerte, tendencia a dormirse sin querer durante el día y tensión arterial alta, hacen pensar que su respiración podría interrumpirse mientras duerme. La conversación no permite saberlo con seguridad. Le recomendamos una valoración para decidir qué estudio del sueño necesita. En algunas personas puede hacerse en casa; en otras conviene un estudio más completo.

Parece que duerme mejor en un horario distinto al que necesita seguir. Vamos a registrar ambos horarios y valorar un plan que se adapte a su día a día.

De dónde sale cada párrafo: 1) Aviso de conducción: texto nuevo, pendiente de aprobación · 2) Somnolencia: plantilla de v0.2 · 3) Respiración: plantilla de v0.2 · 4) Horario: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: AVISO-S2, SEGURO-S2, FRE-02, RES-01, RES-06, RES-07, Z1-02, Z1-03, Z1-05, Z1-07, Z1-10, Z1-11.

V-11 · Duración desconocida, frecuencia no respondida y mucho impacto

Caso límite

Caso

«No duermo bien y lo noto muchísimo en el trabajo.»

«Prefiero no responder» no se vuelve a preguntar; «No lo sé» sí, una vez (D-08).

Preguntas y respuestas, en orden (31 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	37 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Rendir en el trabajo como antes» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	No lo sé
7	**Q03 (aclaración)** · ¿Desde cuándo le ocurre? *Respondió «No lo sé»: se pregunta una vez más, y solo una (D-08).*	No lo sé
8	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	No **(supuesta)**
9	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	Prefiero no responder
10	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Me despierto muchas veces y miro el reloj cada hora» **(supuesta)**
11	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 23:45 · intenta dormir: 00:00 · se despierta: 06:30 · se levanta: 06:45 **(supuesta)**
12	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	despertares
13	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	5 horas **(supuesta)**
14	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«No puedo con mi vida, lo noto mucho en el trabajo»
15	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio **(supuesta)**
16	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	No **(supuesta)**
17	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí **(supuesta)**
18	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Nada en especial» **(supuesta)**
19	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ninguna de estas **(supuesta)**
20	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
21	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
22	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No **(supuesta)**
23	**I1** · ¿Le cuesta dormir incluso cuando tiene tiempo y un lugar adecuados?	Sí
24	**I2** · ¿Esto afecta a su día a día o le produce un malestar importante?	Sí
25	**I3** · ¿Ocurre al menos 3 noches por semana y desde hace 3 meses o más?	No lo sé
26	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
27	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
28	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
29	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	Prefiero no responder
30	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
31	**Z1** · Esto es lo que he entendido: se despierta varias veces por la noche; durante el día nota cansancio. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
32	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Que alguien me ayude pronto» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	I · Dificultad para dormir: ¿terapia o apoyo?
Reglas aplicadas	R02 · Edad y datos que faltan → Información insuficiente (Información incompleta)
Acción principal	Información insuficiente
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Ninguna
Datos que faltan	S3, Q03 (desde cuándo), Q05 (noches por semana)

Texto final, tal como lo vería la persona

Todavía me falta saber si duerme muy poco varias noches seguidas y aun así tiene una energía fuera de lo habitual, desde cuándo le ocurre y cuántas noches por semana le ocurre para orientarle mejor. Puede responder de forma aproximada o decir que no lo sabe. Si prefiere no seguir y el problema persiste o le afecta mucho, puede consultar con un profesional.

De dónde sale cada párrafo: 1) Información incompleta: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: DIF-02, Z1-01, Z1-04, DAT-04, DAT-06, DAT-07.

V-12 · Insomnio y posible apnea, con complejidad

Caso límite

Caso

«Desde hace un año duermo fatal, ronco y me despierto ahogándome. Tomo tramadol por la espalda.»

«me despierto ahogándome» no es un término de riesgo de S1 (habla de la noche, no de ahora).

Preguntas y respuestas, en orden (35 preguntas y 1 texto para leer)

Nº	Pregunta	Respuesta
1	**Edad** · ¿Qué edad tiene?	63 años **(supuesta)**
2	**S1 (al inicio)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva?	No **(supuesta)**
3	**S4 (al inicio)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo?	No **(supuesta)**
4	**Q01** · Cuénteme, ¿qué le preocupa de su sueño?	El relato del caso (arriba)
5	**Q02** · ¿Qué le gustaría que mejorara?	«Dormir sin sobresaltos» **(supuesta)**
6	**Q03** · ¿Desde cuándo le ocurre?	1 año
7	**Q04** · ¿Recuerda si cambió algo en su vida cuando empezó?	Sí «Empezó cuando me operaron de la espalda» **(supuesta)**
8	**Q05** · En una semana habitual, ¿cuántas noches le ocurre?	4 noches por semana
9	**Q06** · Cuénteme cómo suele ser una noche, desde que se acuesta hasta que se levanta.	«Me cuesta coger postura por el dolor y me despierto varias veces» **(supuesta)**
10	**Q07** · ¿A qué hora se acuesta, intenta dormir, se despierta y se levanta?	se acuesta: 22:45 · intenta dormir: 23:00 · se despierta: 06:30 · se levanta: 07:00 **(supuesta)**
11	**Q08** · ¿Qué parte de la noche le resulta más difícil?	despertares
12	**Q09** · Aproximadamente, ¿cuánto cree que duerme en total?	5 horas **(supuesta)**
13	**Q10** · ¿Cómo le afecta al día siguiente?	«Estoy agotado y de peor humor» **(supuesta)**
14	**Q11** · ¿Siente cansancio, llega a quedarse dormido sin querer, o ambas cosas?	cansancio **(supuesta)**
15	**Q12** · ¿Suele dormir siesta o cabecear durante el día?	Sí **(supuesta)**
16	**Q13** · ¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?	Sí **(supuesta)**
17	**Q14** · ¿Hay alguna molestia, enfermedad o tratamiento que influya en su descanso?	«Dolor de espalda, tomo tramadol»
18	**Q15** · ¿Ronca fuerte, le han visto dejar de respirar o se despierta con sensación de ahogo?	Ronca fuerte, se despierta con sensación de ahogo
19	**Q16** · ¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?	No **(supuesta)**
20	**Q17** · ¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?	No **(supuesta)**
21	**Q18** · Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?	No **(supuesta)**
22	**I1** · ¿Le cuesta dormir incluso cuando tiene tiempo y un lugar adecuados?	Sí
23	**I2** · ¿Esto afecta a su día a día o le produce un malestar importante?	Sí
24	**R2a** · ¿Ronca a menudo?	Sí
25	**R2b** · ¿Se duerme sin querer?	No **(supuesta)**
26	**R2c** · ¿Tiene la tensión alta?	No **(supuesta)**
27	**R3** · ¿Duerme solo o no sabe si ronca?	No **(supuesta)**
28	**R4** · Si hay sospecha: ¿hay enfermedad cardiopulmonar relevante, ictus, opioides, debilidad respiratoria o insomnio grave?	opioides
29	**R6** · ¿Ya hubo un estudio respiratorio domiciliario negativo, dudoso o no válido?	No **(supuesta)**
30	**Protección** · Mensaje de protección antes de S1-S4 (v0.2, p. 9)	Leído
31	**S1 (confirmación)** · ¿Ahora tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
32	**S2** · ¿Se queda dormido al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño?	No **(supuesta)**
33	**S3** · ¿Lleva varias noches durmiendo muy poco y, aun así, con energía fuera de lo habitual?	No **(supuesta)**
34	**S4 (confirmación)** · ¿El malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo? *Ya la respondió antes: se confirma en vez de repetirla.*	Sigue igual **(supuesta)**
35	**Z1** · Esto es lo que he entendido: se despierta varias veces por la noche; le ocurre 4 noches por semana; desde hace 1 año; durante el día nota cansancio; ha descrito ronquido fuerte y despertares con sensación de ahogo; toma un tratamiento con opioides. ¿Es correcto?	Sí **(supuesta)**
36	**Z2** · Explicar posible problema y siguiente paso. ¿Qué le facilitaría seguir este plan?	«Que me revisen también la medicación» **(supuesta)**

Resultado

Ramas abiertas	I · Dificultad para dormir: ¿terapia o apoyo?; R · Respiración: elegir la evaluación adecuada
Reglas aplicadas	R05 · Sospecha respiratoria → Consulta / estudio (Polisomnografía); R08 · Prioridad y combinaciones → Consulta / estudio (Insomnio y respiración)
Acción principal	Consulta / estudio
Otras acciones	Ninguna
Prueba a valorar	Polisomnografía en laboratorio
Datos que faltan	Ninguno

Texto final, tal como lo vería la persona

Ha contado dificultades persistentes para dormir y también señales respiratorias como ronquido fuerte y despertares con sensación de ahogo. Pueden coexistir dos problemas. Conviene estudiar su respiración y valorar al mismo tiempo una terapia para el insomnio. El profesional organizará ambos pasos y adaptará el tratamiento si tiene mucho sueño durante el día.

Por el tratamiento con opioides, conviene que le valore un especialista del sueño. Es recomendable que valore una polisomnografía: una prueba que registra cómo duerme, cómo respira y sus movimientos. El profesional confirmará qué prueba aporta más información en su caso.

De dónde sale cada párrafo: 1) Insomnio y respiración: plantilla de v0.2 · 2) Polisomnografía: plantilla de v0.2. Frases y textos a aprobar que usa este caso: DIF-02, FRE-02, RES-01, RES-04, Z1-01, Z1-02, Z1-03, Z1-04, Z1-07, Z1-15, PSG-03.

Textos pendientes de aprobación

Nada de lo que sigue está en v0.2. Hasta que lo apruebes, la aplicación lo trata como provisional y v2.0 sigue desactivada. Marca cada fila o escribe el cambio; si prefieres otra redacción, basta con escribirla al lado.

A. Textos nuevos

Para lo que v0.2 solo da como instrucción al sistema (la acción de Seguridad; el aviso de conducción, la pregunta de lugar seguro y la pausa, p. 10) o deja sin texto (el cuadro reciente). Tono sereno: en medicina del sueño casi no hay urgencias y el objetivo es que la persona siga en The Somnus. Los teléfonos son los confirmados en D-07.

Código	Cuándo se muestra	Texto	¿Aprobado?
SEG-S1	S1 = Sí. Es la acción de la plantilla Seguridad; el texto completo que verá la persona es el de la derecha.	Lo que describe necesita atención antes de seguir hablando de hábitos de sueño. Lo más prudente es que le atiendan ahora mismo. Llame al 112 o pida a alguien que esté con usted que llame por usted. Podemos retomar esta conversación después.	☐ Sí ☐ Cambiar
SEG-S4	S4 = Sí. Es la acción de la plantilla Seguridad; el texto completo que verá la persona es el de la derecha.	Lo que describe necesita atención antes de seguir hablando de hábitos de sueño. No tiene que pasar por esto a solas. Puede llamar ahora al 024 (línea de atención a la conducta suicida): es gratuita, confidencial y atiende las 24 horas del día. Si siente que el peligro es inmediato, llame al 112. Podemos retomar esta conversación después.	☐ Sí ☐ Cambiar
SEG-S3	S3 = Sí. Es la acción de la plantilla Seguridad; el texto completo que verá la persona es el de la derecha.	Lo que describe necesita atención antes de seguir hablando de hábitos de sueño. Le recomendamos que hoy mismo lo comente con su médico o en su centro de salud. Si en algún momento nota que la situación le supera, llame al 112. Podemos retomar esta conversación después.	☐ Sí ☐ Cambiar
AVISO-S2	Aviso a quien se duerme al conducir o al usar maquinaria (S2 = Sí). Se muestra en ese momento de la entrevista, antes de seguir, y otra vez en el texto final, justo antes del texto de somnolencia. v0.2 p. 10 solo dice «No conducir ni usar maquinaria. Evaluación prioritaria».	Si conduce o maneja maquinaria, sobre todo por trabajo, lo más seguro es que no lo haga mientras tenga este sueño y hasta que un profesional lo valore. Si el sueño le sorprende al volante, pare en cuanto pueda en un lugar seguro y descanse. La somnolencia suele tener solución, y por eso merece la pena pedir esa valoración pronto. Si conduce por trabajo, el servicio de salud laboral de su empresa también puede ayudarle.	☐ Sí ☐ Cambiar
SEGURO-S2	Pregunta que sigue al aviso en cuanto S2 = Sí, antes de seguir con la entrevista. v0.2 p. 10: «S2: primero advertencia; seguir solo si está en un lugar seguro». Cualquier respuesta que no sea «Sí» pausa la entrevista.	Antes de seguir: ¿está ahora en un lugar seguro, sin conducir ni manejar maquinaria?	☐ Sí ☐ Cambiar
PAUSA-S2	Lo que se muestra si, tras el aviso, la persona no está en un lugar seguro: la entrevista se pausa.	Lo importante ahora es su seguridad. Si está conduciendo o manejando maquinaria, pare en cuanto pueda en un lugar seguro y descanse. Podemos seguir esta conversación cuando esté a salvo.	☐ Sí ☐ Cambiar
RECIENTE	Cuadro reciente con mucho impacto (I1 e I2 = Sí, menos de 3 meses). v0.2 p. 5: «Un cuadro reciente con mucho impacto también merece ayuda clínica, sin esperar tres meses», pero no da plantilla.	Nos ha contado que desde hace poco le cuesta dormir y que esto le está afectando mucho en su día a día. Cuando el problema es reciente, muchas veces mejora en unas semanas. Aun así, como le afecta tanto, no hace falta esperar: conviene que lo comente con un profesional, que puede ayudarle ya. Mientras tanto, puede seguir aquí y anotar cómo duerme para revisarlo juntos.	☐ Sí ☐ Cambiar

B. Catálogo de frases para los huecos [..]

Cada hueco de las plantillas se rellena con frases cortas de esta lista cerrada, elegidas por la respuesta exacta que se indica. Nunca se copian las palabras de la persona; solo los números que ha dado (noches por semana, duración). Cuando una lista admite varias frases, se unen con «y» en el orden de la tabla. En las frases, «N» es el número de noches que ha dado la persona y «(duración)» la duración que ha dado (por ejemplo, «6 meses»).

Qué parte de la noche le cuesta (Q08)

Rellena [dificultad] en la plantilla Insomnio.
Se usan todas las frases que se cumplan.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
DIF-01	le cuesta dormirse	Q08 incluye «dormirse».	☐ Sí ☐ Cambiar
DIF-02	se despierta varias veces por la noche	Q08 incluye «despertares».	☐ Sí ☐ Cambiar
DIF-03	se despierta antes de lo que querría	Q08 incluye «despertar antes de lo deseado».	☐ Sí ☐ Cambiar
DIF-00	le cuesta dormir bien	Si no se cumple ninguna de las anteriores, y I1 = Sí («¿Le cuesta dormir incluso cuando tiene tiempo y un lugar adecuados?»).	☐ Sí ☐ Cambiar

Cuántas noches por semana (Q05; si falta, I3)

Rellena [frecuencia] en la plantilla Insomnio.
Se usa la primera que se cumpla.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
FRE-01	1 noche por semana	Q05 = 1.	☐ Sí ☐ Cambiar
FRE-02	N noches por semana	Q05 entre 2 y 6.	☐ Sí ☐ Cambiar

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
FRE-03	todas las noches	Q05 = 7.	☐ Sí ☐ Cambiar
FRE-00	al menos 3 noches por semana	Si no se cumple ninguna de las anteriores, y I3 = Sí («¿Ocurre al menos 3 noches por semana y desde hace 3 meses o más?»).	☐ Sí ☐ Cambiar

Desde cuándo (Q03; si falta, I3)

Rellena [duración] en la plantilla Insomnio.
Se usa la primera que se cumpla.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
DUR-01	(duración)	Q03 con duración respondida.	☐ Sí ☐ Cambiar
DUR-00	3 meses o más	Si no se cumple ninguna de las anteriores, y I3 = Sí («¿Ocurre al menos 3 noches por semana y desde hace 3 meses o más?»).	☐ Sí ☐ Cambiar

Cómo le afecta durante el día (Q11 e I2; nunca el texto libre de Q10)

Rellena [impacto] en la plantilla Insomnio.
Se usa la primera que se cumpla.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
IMP-01	esto afecta a su día a día: nota cansancio y a veces le vence el sueño sin querer	Q11 = «ambas cosas».	☐ Sí ☐ Cambiar
IMP-02	esto afecta a su día a día y a veces le vence el sueño sin querer	Q11 = «quedarse dormido sin querer».	☐ Sí ☐ Cambiar
IMP-03	esto afecta a su día a día y nota cansancio	Q11 = «cansancio».	☐ Sí ☐ Cambiar
IMP-00	esto afecta a su día a día	Si no se cumple ninguna de las anteriores, y I2 = Sí («¿Esto afecta a su día a día o le produce un malestar importante?»).	☐ Sí ☐ Cambiar

Señales respiratorias confirmadas (Q15, R1, R2, R3)

Rellena [Pausas/ahogos/otras señales confirmadas] en la plantilla Respiración, presentada así: «Algunas señales que ha contado, como …,»; si no hay ninguna: «Algunas señales que ha contado».
Rellena [señal respiratoria] en la plantilla Insomnio y respiración, presentada así: «señales respiratorias como …»; si no hay ninguna: «algunas señales respiratorias».
Se usan todas las frases que se cumplan.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
RES-01	ronquido fuerte	Q15 incluye «Ronca fuerte».	☐ Sí ☐ Cambiar
RES-02	ronquido frecuente	R2a = Sí («¿Ronca a menudo?») y no Q15 incluye «Ronca fuerte».	☐ Sí ☐ Cambiar
RES-03	pausas al respirar que otras personas han observado	Q15 incluye «le han visto dejar de respirar».	☐ Sí ☐ Cambiar
RES-04	despertares con sensación de ahogo	Q15 incluye «se despierta con sensación de ahogo».	☐ Sí ☐ Cambiar
RES-05	pausas al respirar o despertares con sensación de ahogo	R1 respondida «Sí» por la persona, no deducida («¿Hay pausas observadas o despertares repetidos con sensación de ahogo?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
RES-06	tendencia a dormirse sin querer durante el día	R2b = Sí («¿Se duerme sin querer?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
RES-07	tensión arterial alta	R2c = Sí («¿Tiene la tensión alta?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
RES-08	dudas sobre si ronca o hace pausas al dormir	R3 = Sí («¿Duerme solo o no sabe si ronca?»).	☐ Sí ☐ Cambiar

Por qué conviene un especialista y una polisomnografía (R4, R6, D2, N2)

Rellena [motivo concreto] en la plantilla Polisomnografía.
Se usan todas las frases que se cumplan.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
PSG-01	la enfermedad del corazón o de los pulmones que ha mencionado	R4 incluye «enfermedad cardiopulmonar relevante».	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-02	el antecedente de ictus	R4 incluye «ictus».	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-03	el tratamiento con opioides	R4 incluye «opioides».	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-04	la debilidad respiratoria que ha mencionado	R4 incluye «debilidad respiratoria».	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-05	la intensidad de su insomnio	R4 incluye «insomnio grave».	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-06	no conocer todavía otros problemas de salud que puedan influir en su respiración	Rama R abierta y R4 sin dato.	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-07	un estudio del sueño en casa que no permitió aclarar el problema	R6 = Sí («¿Ya hubo un estudio respiratorio domiciliario negativo, dudoso o no válido?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-08	la somnolencia que continúa aunque duerma lo suficiente	D2a = Sí («¿Continúa pese a dormir suficiente?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-09	la pérdida de fuerza al reírse	D2b = Sí («¿Pierde fuerza al reírse, sin perder el conocimiento?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-10	los golpes o lesiones durante el sueño	N2 incluye «lesiones».	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-11	los movimientos violentos durante el sueño	N2 incluye «violencia».	☐ Sí ☐ Cambiar

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
PSG-12	la aparición de estos episodios en la edad adulta	N2 incluye «episodios nuevos en adulto».	☐ Sí ☐ Cambiar
PSG-13	las dudas sobre si podrían ser convulsiones	N2 incluye «dudas con convulsiones».	☐ Sí ☐ Cambiar

Qué dato falta al cerrar (R02)

Rellena [dato] en la plantilla Información incompleta.
Se usan todas las frases que se cumplan.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
DAT-01	su edad	Falta la edad.	☐ Sí ☐ Cambiar
DAT-02	si ahora mismo tiene dificultad intensa para respirar, dolor fuerte en el pecho o una confusión nueva	Falta S1.	☐ Sí ☐ Cambiar
DAT-03	si le vence el sueño al conducir o al hacer algo en lo que podría hacerse daño	Falta S2.	☐ Sí ☐ Cambiar
DAT-04	si duerme muy poco varias noches seguidas y aun así tiene una energía fuera de lo habitual	Falta S3.	☐ Sí ☐ Cambiar
DAT-05	si el malestar le hace sentir que podría hacerse daño o que no está a salvo	Falta S4.	☐ Sí ☐ Cambiar
DAT-06	desde cuándo le ocurre	Falta Q03 (desde cuándo).	☐ Sí ☐ Cambiar
DAT-07	cuántas noches por semana le ocurre	Falta Q05 (noches por semana).	☐ Sí ☐ Cambiar

El cambio que se propone empezar (guía de la plantilla de hábitos, p. 11: «Elegir con la persona»). Si la persona elige uno, se usa ese; si no, el primero que se cumpla.

Rellena [cambio elegido] en la plantilla Hábitos.
Se usa la primera que se cumpla.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
HAB-01	proteger un tiempo fijo para descansar	H4 = Sí («¿Duerme poco porque no puede reservar más tiempo, aunque dormiría más?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
HAB-02	hacer más regular la hora de levantarse, si su vida lo permite	Solo si la persona elige este cambio.	☐ Sí ☐ Cambiar
HAB-03	reducir la cafeína, si nota que le influye	Solo si la persona elige este cambio.	☐ Sí ☐ Cambiar
HAB-04	mejorar la luz o el ruido del dormitorio	Solo si la persona elige este cambio.	☐ Sí ☐ Cambiar
HAB-00	proteger un tiempo fijo para descansar	Si no se cumple ninguna de las anteriores.	☐ Sí ☐ Cambiar

Lo que se ha entendido, para que la persona lo confirme en Z1

Rellena [resumen] en la pregunta Z1.
Se usan todas las frases que se cumplan.

Código	Frase	Se elige cuando	¿Aprobada?
Z1-01	(frases de «Qué parte de la noche le cuesta (Q08)»)	Q08 con al menos una opción.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-02	le ocurre (frases de «Cuántas noches por semana (Q05; si falta, I3)»)	Q05 entre 1 y 7.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-03	desde hace (duración)	Q03 con duración respondida.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-04	durante el día nota cansancio	Q11 = «cansancio».	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-05	durante el día a veces le vence el sueño sin querer	Q11 = «quedarse dormido sin querer».	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-06	durante el día nota cansancio y a veces le vence el sueño sin querer	Q11 = «ambas cosas».	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-07	ha descrito (frases de «Señales respiratorias confirmadas (Q15, R1, R2, R3)»)	Hay al menos una señal respiratoria.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-08	nota una molestia en las piernas que le obliga a moverlas al descansar	Q16 = Sí («¿Una molestia en las piernas le obliga a moverlas cuando está descansando?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-09	le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme	Q17 = Sí («¿Le han visto caminar, gritar o dar golpes mientras duerme?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-10	no siempre tiene tiempo o un lugar adecuados para dormir	Q13 = No («¿Tiene tiempo y un lugar adecuados para dormir?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-11	duerme mejor cuando puede elegir su horario	Q18 = Sí («Si puede elegir su horario, ¿duerme mejor?»).	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-12	tiene un trastorno bipolar	Dato confirmado en Z1: trastorno bipolar.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-13	tiene epilepsia	Dato confirmado en Z1: epilepsia.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-14	hay un embarazo en curso	Dato confirmado en Z1: embarazo.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-15	toma un tratamiento con opioides	Dato confirmado en Z1: toma de opioides.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-16	consume sustancias que pueden influir en el sueño	Dato confirmado en Z1: consumo de sustancias.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-17	toma medicación que puede influir en el sueño	Dato confirmado en Z1: medicación que influye en el sueño.	☐ Sí ☐ Cambiar
Z1-00	por ahora no ha descrito ninguna dificultad concreta con el sueño	Si no se cumple ninguna de las anteriores.	☐ Sí ☐ Cambiar